ENFERMEDADES BENIGNAS Y TRASTORNOS MOTORES DEL ESÓFAGO

DRA. HEBE ANGELICA AVILÉS

ACALASIA: FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

- Pérdida de neuronas inhibitorias del plexo mientérico de Auerbach → déficit de óxido nítrico y VIP → falta de relajación del EEI y aperistalsis.
- Clínica: disfagia a sólidos y líquidos desde el inicio, regurgitación no ácida, dolor torácico, pérdida de peso; la pirosis va en contra del diagnóstico.
- Diagnóstico: endoscopia primero (descartar pseudoacalasia por tumor de cardias); esofagograma en "pico de pájaro"; manometría de alta resolución es el estándar de oro (IRP >15mmHg).

COMPLICACIONES DE LA ACALASIA NO TRATADA

- Megaesofago (dilatación masiva), neumonía aspirativa recurrente, y mayor riesgo a largo plazo de carcinoma escamoso de esófago; se recomienda vigilancia endoscópica en enfermedad de larga evolución.

SUBTIPOS DE ACALASIA (CHICAGO v4.0)

- Subtipo I (clásica): aperistalsis completa; respuesta moderada-buena a miotomía o dilatación.
- Subtipo II (panpresurización): mejor pronóstico, excelente respuesta a miotomía de Heller.
- Subtipo III (espástica): contracciones prematuras; pronóstico reservado, requiere miotomía extendida o POEM.

PATOLOGÍA ESTRUCTURAL BENIGNA

- Divertículo de Zenker: por el triángulo de Killian, disfunción del cricofaríngeo; tto: miotomía + diverticulectomía/pexia.
- Anillo de Schatzki: disfagia súbita a sólidos ("síndrome del restaurante"); se trata con dilatación endoscópica.

TRATAMIENTO DE LA ACALASIA

- Miotomía de Heller laparoscópica + funduplicatura parcial (Dor o Toupet): tratamiento de elección, evita reflujo iatrogénico.
- POEM (miotomía endoscópica peroral): alta eficacia, sobre todo en subtipo III; mayor riesgo de reflujo posterior.
- Dilatación neumática y toxina botulínica: opciones restrictivas para ancianos o alto riesgo quirúrgico.

SEGUIMIENTO POSTRATAMIENTO

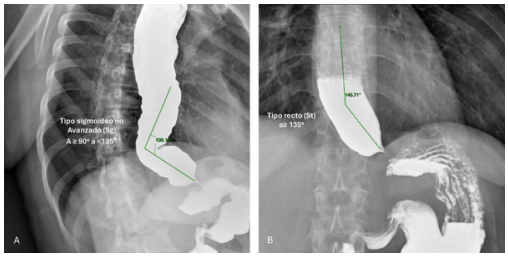
- Control endoscópico y manométrico tras miotomía o POEM; el reflujo patológico posterior se vigila con pHmetría si hay síntomas persistentes.

TRASTORNOS MOTORES NO ACALÁSICOS

- Espasmo esofágico distal: contracciones prematuras con EEI normal; imagen en "sacacorchos"; dolor torácico y disfagia intermitente.
- Esófago hipercontráctil (jackhammer): contracciones de amplitud extrema; dolor torácico no cardíaco.
- Aperistalsis esofágica: ausencia total de peristalsis, asociada a esclerodermia; disfagia continua y pirosis severa.

ERGE: INDICACIÓN QUIRÚRGICA

- Funduplicatura (Nissen 360° o parcial) indicada si: respuesta incompleta/nula a IBP, intolerancia farmacológica, complicaciones estructurales (esofagitis severa, estenosis péptica) o síntomas respiratorios recurrentes por microaspiración.



ENFERMEDADES BENIGNAS Y TRASTORNOS MOTORES DEL ESÓFAGO

DRA. HEBE ANGELICA AVILÉS

MANOMETRÍA DE ALTA RESOLUCIÓN

- Hasta 36 canales a 1 cm con 12 sensores por canal (432 puntos de presión): mapeo topográfico tridimensional que orienta entre endoscopia y cirugía.

ETIOPATOGENIA DE LA ACALASIA

- Pérdida inflamatoria de neuronas inhibitorias del plexo de Auerbach → déficit de óxido nítrico y VIP → EEI que no se relaja y aperistalsis del cuerpo.

PSEUDOACALASIA

- Infiltración tumoral del cardias (adenocarcinoma gástrico/UGE, la más frecuente), metástasis (pulmón, mama, páncreas, linfoma), Chagas, radioterapia, amiloidosis o secuela de funduplicatura/banda.

CLÍNICA DE LA ACALASIA

- Disfagia motora continua a sólidos y líquidos desde el inicio, regurgitación no ácida, dolor torácico con la ingesta y pérdida de peso progresiva.
- La pirosis va en contra del diagnóstico.

ENDOSCOPIA EN LA ACALASIA

- Primera prueba: descarta obstrucción orgánica y pseudoacalasia; dilatación con restos y cardias puntiforme que cede con suave resistencia.

RADIOLOGÍA EN LA ACALASIA

- Rx de tórax: sin burbuja gástrica y mediastino ensanchado. Esofagograma: dilatación con afilamiento en «pico de pájaro».

MANOMETRÍA EN LA ACALASIA

- Gold standard: IRP >15 mmHg (falta de relajación del EEI); Chicago v4.0 define tres subtipos.

ACALASIA TIPO I (CLÁSICA)

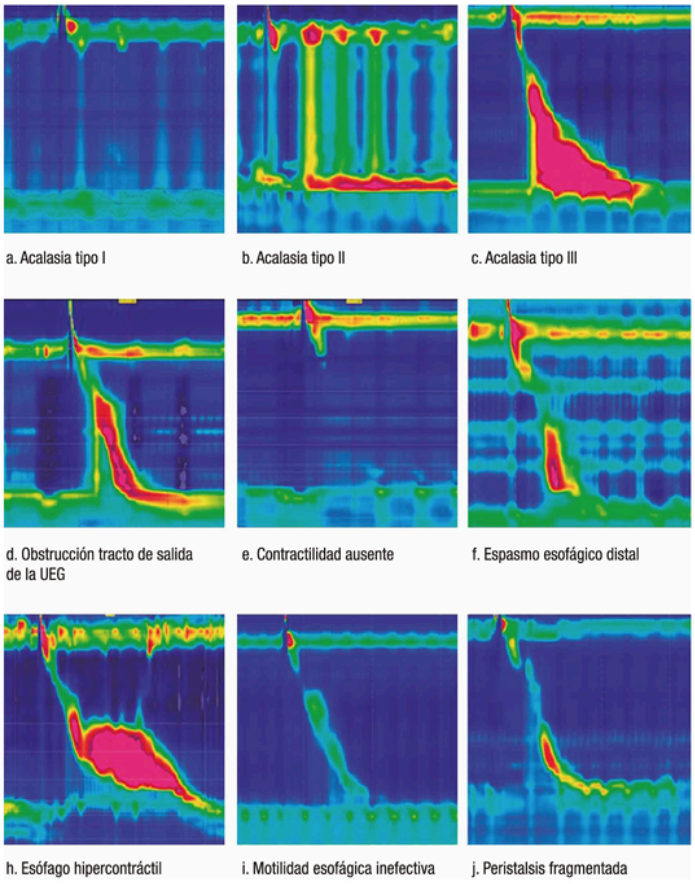
- 100% de degluciones fallidas sin presurización (DCI <450); respuesta moderada a buena con miotomía o dilatación.

ACALASIA TIPO II (PANPRESURIZACIÓN)

- Panpresurización en ≥20% de degluciones; el mejor pronóstico tras Heller o dilatación.

ACALASIA TIPO III (ESPÁSTICA)

- Contracciones prematuras (DL <4,5 s) en ≥20%; mala respuesta a la dilatación: miotomía extendida (POEM).



MIOTOMÍA DE HELLER LAPAROSCÓPICA

- Tratamiento de elección: sección de las capas musculares del esófago distal y EEI + funduplicatura parcial (Dor anterior o Toupet posterior 270°) para evitar reflujo.

POEM

- Miotomía endoscópica por túnel submucoso; muy eficaz, sobre todo en el tipo III; alto riesgo de reflujo posterior (IBP y seguimiento).

DILATACIÓN NEUMÁTICA Y TOXINA BOTULÍNICA

- Reservadas a ancianos, comorbilidad o alto riesgo quirúrgico: la dilatación rompe fibras del EEI y la toxina inhibe la liberación de acetilcolina.

ESPASMO ESOFÁGICO DISTAL

- Contracciones prematuras (DL <4,5 s) en ≥20%, peristalsis normal alternante e IRP normal; dolor torácico y disfagia intermitente; esofagograma en «sacacorchos».

ENFERMEDADES BENIGNAS Y TRASTORNOS MOTORES DEL ESÓFAGO

DRA. HEBE ANGELICA AVILÉS

ESÓFAGO HIPERCONTRÁCTIL (JACKHAMMER)

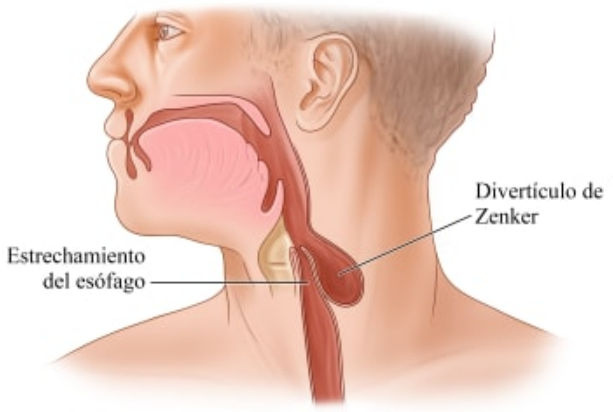
- DCI >8000 mmHg·s·cm en ≥20% con coordinación conservada; dolor torácico no cardíaco severo y disfagia; relajantes del músculo liso.

APERISTALSIS ESOFÁGICA

- Ausencia de peristalsis (DCI <100 o 100% fallidas) por atrofia o esclerodermia; disfagia continua y pirosis severa por EEI incompetente; manejo sintomático.

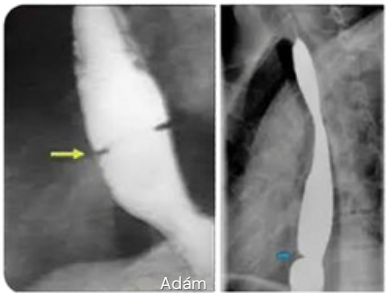
DIVERTÍCULO DE ZENKER

- Seudodivertículo de pulsión por el triángulo de Killian (constrictor inferior y cricofaríngeo), por disfunción del cricofaríngeo.
- Miotomía cricofaríngea + diverticulectomía o diverticulopexia.

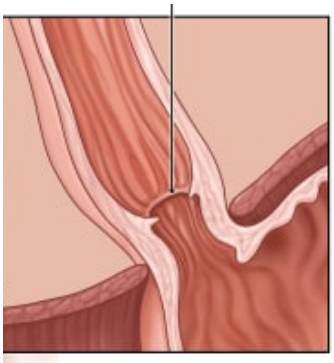


ANILLO DE SCHATZKI

- En la unión escamocolumnar: disfagia mecánica súbita a sólidos («síndrome del restaurante»); dilatación o sección endoscópica.







CIRUGÍA DE LA ERGE

- Funduplicatura (Nissen 360° o parcial) si hay respuesta incompleta a IBP, intolerancia, complicaciones (esofagitis severa, estenosis) o microaspiración.

